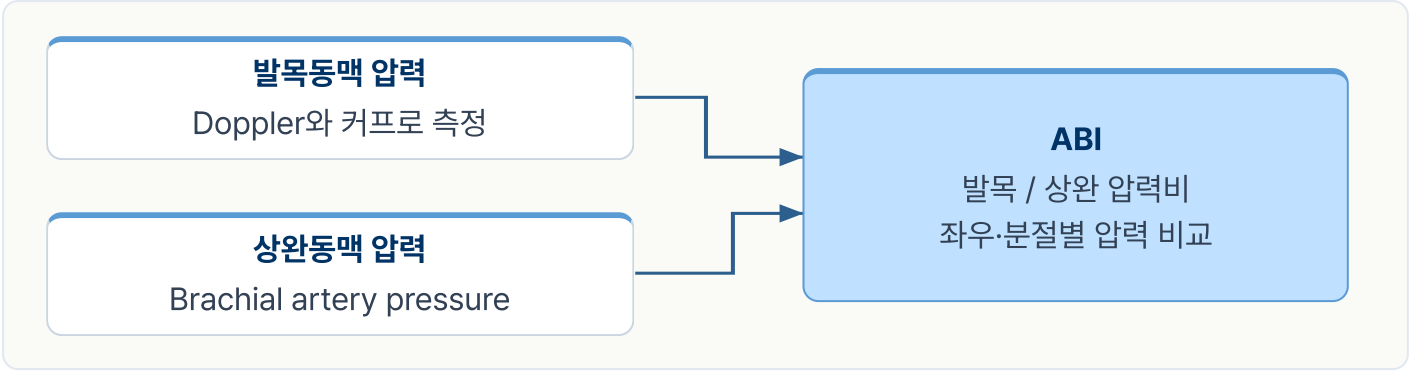
의료진 진료 카드 · ASL-011

ABI · 측정값에서 다음 검사까지

발목상완지수(ABI): 발목동맥과 상완동맥의 압력비. 맥박·증상·상처와 함께 해석한다.

ABI의 구조 · 발목 압력을 상완 압력과 비교



본강의 · ABI 해석표

≥0.91	정상 소견으로 제시.
0.71~0.90	경증 폐쇄.
0.41~0.70	중등도 폐쇄.
0.00~0.40	중증 폐쇄.

본강의 · 압력과 진찰

Doppler·분절압	커프 압박으로 Doppler 신호가 사라지는 시점의 압력을 측정한다고 설명. 분절별 압력이 급격히 낮아지는 위치로 협착 수준을 가늠.
맥박 촉진	대퇴·슬와동맥과 족배·후경골동맥을 좌우 비교. 맥박이 약하거나 촉지되지 않으면 병변 가능성을 평가한다.

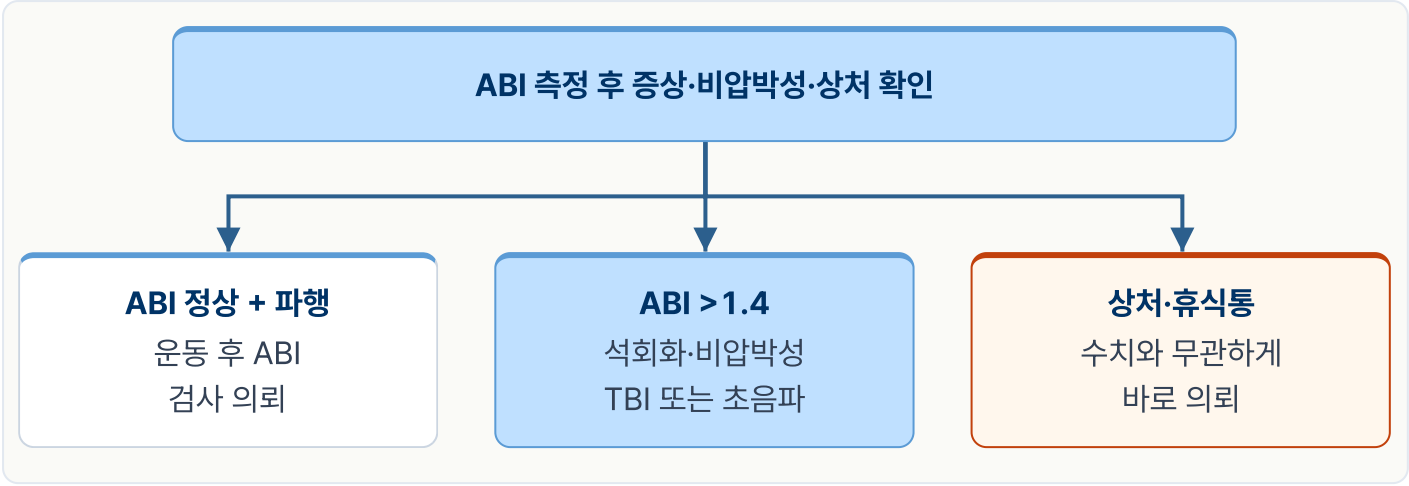
연자 Q&A: 상처 또는 휴식기 통증이 있으면 ABI 결과와 무관하게 바로 의뢰. 장비가 없어도 족부 맥박이 약하거나 촉지되지 않으면 의뢰 사유가 된다.

의료진 진료 카드 · ASL-011

ABI · 정상·높은 값에서도 분기

안정 시 정상인데 전형적 파행이 있거나, 혈관이 압박되지 않아 높은 값이면 추가검사로 연결한다.

연자 Q&A · 증상과 비압박성을 먼저 확인



본강의·연자 Q&A · 서로 다른 제시값

본강의	비압박성이면 ABI >1.30으로 위음성 가능. 당뇨 환자 5~10%, 고령·투석 CKD·장기 스테로이드 복용에서 설명.
연자 Q&A	정상 범위 0.9~1.4, ABI <0.9는 PAD 진단, >1.4는 석회화로 TBI·초음파 연결. 수치 경계는 본강의 해석표와 구분해 읽는다.
운동 후 검사	본강의는 안정 시보다 운동 후 발목압 ≥20% 감소, 혈압 회복 ≥3분이면 비정상으로 제시. 전형적 파행인데 안정 ABI가 정상이면 운동 ABI 의뢰.

연자 Q&A · ABI와 다른 검사의 역할

ABI vs PWV	ABI <0.9는 혈관조영술의 ≥50% 협착에 특이도 ≥95%·민감도 70~80%로 소개. PWV는 경직도 지표로 폐쇄 진단이 아니며 PAD에서는 낮게 나올 수도 있다.
누구를 검사할까	≥65세, 50~64세이며 당뇨·흡연·CKD·가족력, 다른 부위 죽상경화증. 당뇨는 ≥50세 또는 흡연·고혈압·이상지질혈증·유병 ≥10년·미세혈관합병증 등 위험인자가 있으면 증상과 무관하게 ABI를 고려한다는 답변.

연자 Q&A: 심혈관 위험 재분류용 대퇴동맥 초음파는 양측 CFA·분지부~근위 SFA의 플라크를 보는 검사. 무증상 ≥50% 협착은 먼저 ABI, <0.9이면 의뢰하여 병변 범위·추적을 평가. 정상·무증상은 위험인자 관리와 추적을 제시했다.